

Dalla Paura alle Difese

Salute Mentale · Sessione 04 · 11.03.2026

Questa lezione è una delle più dense del corso — e anche una delle più utili per il tuo futuro lavoro. Partiamo da un mito greco, atterriamo nella neurobiologia delle emozioni, e arriviamo a capire perché i tuoi utenti a volte si comportano in modo che sembra incomprensibile. Buckle up.

Il mito di Perseo e la Gorgone: la paura in forma di storia

Il prof apre con un mito — e non lo fa per caso. Le storie che durano millenni raccontano verità psicologiche universali, quelle che gli antichi non avevano un altro modo per dire.

Medusa è la Gorgone mortale, la "paura alla sua ennesima potenza": chiunque la guardi direttamente negli occhi viene pietrificato. Lei non aggredisce nessuno — vive nei suoi luoghi lontani e inaccessibili. Il problema è se vai da lei e la guardi direttamente.

Perseo viene incaricato di tagliarle la testa. Prima di affrontarla, scende nei luoghi inferi e si attrezza: riceve un sacco per contenere la testa recisa, calzari alati per muoversi velocemente, l'elmo di Ade che rende invisibili. Poi ottiene due doni fondamentali da due divinità:

- Da **Atena** (dea della sapienza e della guerra): uno **scudo lucido come uno specchio**. Il prof sottolinea che il verbo "riflettere" vale sia per gli specchi che per il pensiero — non è un caso.
- Da **Erme**s: un falchetto per tagliare la testa.

Arrivato vicino alla dimora di Medusa, **Perseo capisce dove si trova vedendo i corpi pietrificati di chi aveva tentato prima di lui**. Aspetta che lei si addormenti, poi — senza guardarla direttamente — usa lo scudo come specchio per vederla in modo

indiretto. **La decapita mentre dorme.** Da quel momento in poi, quella testa diventerà il suo "superpotere" per affrontare altre minacce.

Cosa ci dice questo mito sulla paura

Il mito trasmette almeno tre messaggi fondamentali:

1. **Le paure, anche le più grandi, si possono affrontare** — a condizione di attrezzarsi bene. Non basta il coraggio a testa bassa: chi si è avvicinato a Medusa senza preparazione è rimasto di sasso.
2. **Occorre un medium** — non si guarda la paura frontalmente, ma di riflesso. Lo scudo di Atena rappresenta la capacità di *riflettere*, di pensare, di mediare l'incontro diretto con ciò che ci spaventa.
3. **Una volta affrontata, la paura diventa risorsa** — la testa di Medusa, per quanto macabra, diventa un capitale che Perseo usa per aiutare altri. **Aver elaborato le proprie paure non ti rende automaticamente esperto delle paure altrui** (attenzione: questo sarebbe **empatia egocentrica**, una forma di **arroganza relazionale**), ma ti rende più capace di stare vicino a qualcuno senza andare in tilt.

Il lato oscuro: chi è davvero Medusa?

Qui il prof ribalta il punto di vista in modo potente, citando **Ovidio** (*Metamorfosi, libro IV*).

Medusa **non era nata mostro**. Era la più bella delle tre sorelle Gorgoni, la più desiderata. Un giorno Poseidone la violenta nel tempio di Atena. Poi — Atena trasforma Medusa nel mostro che conosciamo: capelli di serpenti, sguardo pietrificante. Non punisce l'aggressore. Trasforma la vittima.

Il "mostro" è il risultato di una mostruosità subita. Medusa non aggredisce nessuno di propria iniziativa: se ne sta a casa sua. È pericolosa solo se ci vai tu.

Il prof collega questo direttamente al lavoro sociale:

"Noi vediamo il mostro. Ma spesso non vediamo ciò che li ha trasformati in mostro."

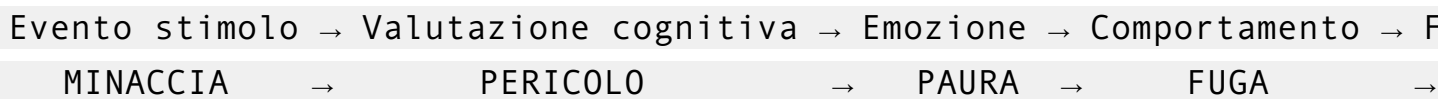
I vostri utenti "difficili", scontroso, inavvicinabili — a volte sono Meduse. Persone che hanno subito qualcosa di orribile e che si sono costruite una corazza per sopravvivere. La "mostruosità" che vedete è spesso una **protezione**, non un'identità.

Anatomia della paura: come funziona un'emozione

Paura: definizione e funzione evolutiva

La **paura** è prima di tutto un'**emozione**. Darwin (1872) la collegava all'etimologia di qualcosa di *pericoloso e improvviso*. La paura ci predispone a individuare il pericolo tempestivamente e a reagire.

Funzionalmente, la paura segue una **filiere** precisa (elaborazione di Pezzoli da Plutchik, 2017):



Attenzione: la **valutazione cognitiva** è *proto-cognitiva*, cioè veloce e automatica — non è un ragionamento cosciente. Può prendere cantonate, ma conta la velocità. Pensa a come in un bosco reagisci al bastone che sembra un serpente: la reazione arriva prima del pensiero.

Emozioni vs. sentimenti vs. umori

Il prof fa una distinzione che tornerà più volte nel corso:

	Emozione	Sentimento	Umore
Oggetto	Sì, specifico	Sì/No (può essere diffuso)	No
Intenzionalità			No

	Emozione	Sentimento	Umore
	No (non si sceglie)	Sì (posso scegliere di amare)	
Durata	Breve	Lunga	Prolungata/ diffusa
Esempio	Paura di un cane	Amore per una persona	Tristezza di fondo

La differenza fondamentale: le emozioni *non si scelgono*, i sentimenti sì.

Le tre risposte etologiche alla paura

A livello biologico, di fronte a una minaccia percepita, ci sono tre risposte possibili:

1. **Fuga** — la risposta comportamentale tipica
2. **Attacco** — quando la fuga è impossibile (il gatto in un angolo che non può scappare)
3. **Mimetismo/immobilità** — sparire dalla vista del predatore

Il prof collega immediatamente queste tre al lavoro sociale: Un utente tossicodipendente che ti attacca durante un colloquio non è necessariamente aggressivo per natura — potrebbe essere un gatto in un angolo. Se non gli dai vie di fuga (fisiche, psicologiche, relazionali), l'attacco è la sua unica opzione.

Quando la paura si inceppa: intensità e durata

La paura smette di essere funzionale in due situazioni:

1. Intensità eccessiva → freezing (blocco)

Sopra una certa soglia di **arousal** (attivazione fisiologica), invece di mettere in atto la fuga o l'attacco, ci si blocca. Freud lo aveva già notato: "Se l'angoscia raggiunge un'intensità eccessiva, si dimostra assai inappropriata, paralizza ogni azione, compresa quella della fuga."

Il prof racconta di una paziente molestata dal parrucchiere che si è bloccata completamente invece di reagire — e questo blocco è stato interpretato dall'aggressore come consenso. Il freezing non è una scelta: è una risposta automatica all'iper-attivazione.

Implicazione pratica: quando un utente è troppo attivato emotivamente, il tuo primo compito è abbassare quell'attivazione. Solo dopo si può lavorare. Voi siete lo "scudo di Atena" — mediate l'incontro con la paura.

2. Durata eccessiva → esaurimento delle risorse

Un pericolo percepito che dura troppo a lungo consuma le risorse del soggetto e può portare a cercare soluzioni temporanee (alcol, farmaci, sostanze) per sospendere l'esposizione.

Il contesto conta: la mappa dell'ambiente

La paura non dipende solo dalla minaccia, ma anche dall'**ambiente** in cui la si vive. Pezzoli presenta uno schema a quattro quadranti:

	Ambiente familiare/ conosciuto	Ambiente non familiare
Minaccia presente	Area di pericolo (ma con risorse)	Area di massimo allarme
Minaccia assente	Area di comfort	Area di attenzione (anticipazione)

Esempio del prof: un migrante che si sente male in un posto dove non conosce la lingua, non sa a chi chiedere aiuto, e chi "dovrebbe" aiutarlo in passato lo ha maltrattato — è nell'area di massimo allarme. La stessa malattia in contesto familiare è gestibile in modo completamente diverso.

Paura vs. ansia: non sono la stessa cosa

Questo è un punto chiave che il prof vuole molto chiaro. **Paura e ansia non sono sinonimi** — non a livello psicologico, e nemmeno a livello neurologico.

- La **paura** ha un oggetto specifico, una minaccia reale e presente. Durata breve. Coinvolge principalmente l'**amigdala**.
- L'**ansia** non ha oggetto definito, è proiettata nel futuro, dura nel tempo. Coinvolge il **Nucleo della stria terminale (BNST)** — *Bed Nucleus of the Stria Terminalis* — una struttura limbica diversa (Grillon, 2008).

L'ansia è, per Plutchik, una combinazione di due emozioni base: **paura + anticipazione**. È la paura privata del suo oggetto e del suo tempo presente.

La classificazione clinica di ansia normale vs. patologica segue questi criteri:

Criterio	Ansia normale	Ansia patologica
Intensità	Lieve-moderata	Moderata-intensa
Durata	Limitata nel tempo	Lunga o con postumi
Frequenza	Episodi poco frequenti	Episodi frequenti o continui
Reazione	Appropriata alla situazione	Inappropriata/sproporzionata
Sofferenza	Limitata e temporanea	Evidente, frequente
Conseguenze	Compromette poco la funzionalità	Compromissione della libertà/funzionalità

Le tre fonti di angoscia: Freud e "Il disagio della civiltà"

Freud, in *Il disagio della civiltà* (1930), identifica tre fonti fondamentali di minaccia per l'essere umano:

1. **Il corpo** — ci ammaliamo, deperiamo, moriamo. Il corpo può persino non piacerci — e anche questo diventa una fonte di angoscia.
2. **La natura** — terremoti, malattie, catastrofi. Da sempre fonte di minaccia per l'uomo.
3. **Le relazioni con gli altri** — per Freud la più importante. Le altre persone possono essere la nostra rovina, ma anche la nostra salvezza.

Il prof cita la metafora dei **porcospini di Schopenhauer** (*Parerga e paralipomena*): si avvicinano per scaldarsi, ma le spine si feriscono e devono allontanarsi. Trovano alla fine una distanza moderata — né troppo fredda né troppo pungente.

I meccanismi di difesa: cosa sono e perché esistono

Definizione fondamentale

I **meccanismi di difesa** (MDD) sono: - **Automatici** (si attivano senza decisione cosciente) - **Inconsci** (non se ne è consapevoli) - **Attivati dall'Io** sotto la pressione dell'angoscia - **Scopo principale**: difendere il soggetto dall'angoscia — **non** dalla minaccia in sé

Il punto cruciale: i MDD difendono dall'**angoscia**, non dal **pericolo** che la genera. Con l'esempio del neo che cambia aspetto sulla pelle: il diniego ti toglie l'angoscia ma non ti protegge dal melanoma che intanto avanza.

I tre tipi di angoscia (Anna Freud)

L'angoscia che i MDD devono fronteggiare può provenire da tre istanze: - **Angoscia istintuale** (dall'Es che preme per soddisfazione immediata) - **Angoscia del reale** (dalla realtà esterna minacciosa) - **Angoscia morale** (dal Super-Io che impone divieti e sanzioni)

Come valutare i meccanismi di difesa

Tre criteri fondamentali (Anna Freud, poi ripresi da Perrotta, 2020):

1. **Age adequateness** — è adeguato all'età? Un bambino che nega il pericolo è normale; un adulto che lo fa sistematicamente no.
 2. **Intensity** — quanto distorce la realtà?
 3. **Balance** — il soggetto usa una varietà di difese o è bloccato sempre sulle stesse?
-

I meccanismi di difesa primitivi

Si sviluppano nella prima infanzia. Sono drastici, semplici, molto efficaci nel togliere l'angoscia — ma distorcono molto la realtà e impediscono l'incontro con il problema che la genera.

Regola pratica del prof: quando osservate in un adulto meccanismi di difesa molto primitivi, vuol dire che è **molto angosciato**. Il tipo di difesa vi dà il grado di angoscia. Non è un adulto "difficile" per carattere — è profondamente spaventato.

Ritiro primitivo

Il più antico. Di fronte a una sovrastimolazione che non si può gestire, il soggetto si "ritira". Il bambino si addormenta alla festa rumorosa. Nell'adulto: uso di sostanze, videogiochi in modo ossessivo, rifugio in mondi fantastici. Nell'adulto, la dominanza di questo meccanismo può segnalare una personalità **schizoide**.

Diniego

Non si *vede* ciò che genera angoscia. Non è la chiusura verso il mondo del ritiro primitivo: è la negazione selettiva della realtà a livello percettivo.

Esempio del prof: genitori che non si accorgono della dipendenza del figlio — non perché siano stupidi o disattenti, ma perché vedere quella cosa genererebbe un'angoscia insostenibile.

Il diniego è ancora più radicale della rimozione: nella rimozione c'è un primo contatto con la realtà che poi viene "dimenticata"; nel diniego la realtà angosciante non viene proprio percepita.

Proiezione

Si attribuisce a qualcun altro un proprio stato interno (pensiero, emozione, impulso) che risulterebbe troppo angosciante se riconosciuto come proprio.

Introiezione

Il contrario della proiezione: si fanno proprie caratteristiche, modi di fare, valori dell'altro. La forma patologica più estrema è l'**identificazione con l'aggressore**: di fronte all'impotenza di essere vittima, l'unica via d'uscita percepita è diventare come chi ti fa del male.

Identificazione proiettiva

Meccanismo complesso, molto presente nell'adolescenza e in alcuni disturbi di personalità. Non basta proiettare un contenuto sull'altro: si agisce nella relazione in modo da far sì che l'altro *provi davvero* ciò che gli è stato proiettato.

Un utente arriva dall'assistente sociale frustrato e convinto che nessuno riesca ad aiutarlo. L'assistente costruisce un progetto dopo l'altro — e l'utente fa fallire tutti. Alla fine, l'assistente sociale prova esattamente le stesse emozioni dell'utente all'inizio: frustrazione, senso di inadeguatezza, rabbia. Ha vissuto dall'interno il mondo interno dell'utente.

Scissione

Il mondo viene diviso in buoni e cattivi, tutto bianco o tutto nero. È normale nei bambini piccoli (e nelle fiabe: la fata buona e la strega cattiva). Il problema è quando persiste nell'adulto.

Mélanie Klein ha studiato il passaggio dalla **posizione schizoide** (scissione netta) alla **posizione depressiva** (la capacità di tenere insieme aspetti positivi e negativi della stessa persona).

Idealizzazione e svalutazione

Meccanismi speculari. L'idealizzazione amplifica le qualità positive di qualcuno per sentirsi al sicuro.

Il prof avverte: se un paziente/utente ti idealizza molto, non è (solo) perché sei bravo. È perché è molto angosciato. Quando quella sicurezza viene meno, l'idealizzazione si capovolge in svalutazione immediata.

Controllo onnipotente

Si basa sull'**egocentrismo primitivo** (tutto dipende da me) e sul **narcisismo primario** (io sono il mondo). Il prof sottolinea l'ironia: chi ha bisogno di controllare tutto è spesso molto fragile dentro.

I meccanismi di difesa secondari (o maturi)

Compaiono dopo la prima infanzia. Sono più complessi, distorcono meno la realtà, mantengono un maggiore contatto con la dimensione conflittuale che genera angoscia.

Blocco 1 — Dimenticare: rimozione e dissociazione

Rimozione: sposta nell'inconscio pensieri, idee, affetti che generano angoscia. Si parte da un primo contatto con la realtà, poi si "dimentica".

Dissociazione: crea una discontinuità nell'esperienza mnestica e sensoriale. Usata soprattutto nei traumi. Guardare fuori dal finestrino del treno nel vuoto è una lieve dissociazione; non sentire il proprio corpo durante un abuso è una dissociazione grave.

Blocco 2 — Spostare: formazione reattiva, regressione, capovolgimento, spostamento

Formazione reattiva: si trasforma un affetto negativo nel suo opposto esagerato. Il bambino che odia il fratellino appena nato ma si comporta come il suo migliore papà, prendendosi cura di lui un po' troppo intensamente.

Spostamento: si sposta l'obiettivo di un sentimento su qualcosa di meno "pericoloso". Il datore di lavoro urla agli operai invece di scaricare la frustrazione direttamente su chi la provoca.

Capovolgimento (passivo → attivo): "Io vorrei ricevere attenzioni → do attenzioni agli altri."

Blocco 3 — Separare: isolamento, razionalizzazione, intellettualizzazione, moralizzazione, compartimentalizzazione

Il meccanismo di base di questo gruppo è l'**isolamento degli affetti**: si separa la componente emotiva da quella cognitiva, mettendo da parte la parte che fa male.

Intellettualizzazione: si parla di emozioni in modo distaccato, senza entrarci in contatto.

Razionalizzazione: si costruisce una spiegazione razionale per evitare il contatto emotivo. La volpe che non raggiunge l'uva e dice "tanto non era matura".

Compartimentalizzazione: due dimensioni cognitive incompatibili coesistono nello stesso soggetto senza mai entrare in contatto. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Non è ipocrisia consapevole: le due cose "abitano stanze diverse" e metterle in contatto sarebbe troppo angosciante.

La scala di maturità: un quadro d'insieme

I MDD si organizzano lungo due assi:

- **Asse orizzontale:** comparsa nel tempo (primitivi → maturi)
- **Asse verticale:** grado di distorsione della realtà (alta → bassa) / complessità (bassa → alta)

La classificazione in livelli (adattamento Pezzoli da Perrotta, 2020):

Livello	Tipo	Esempi
7°	Difese mature	Altruismo, affiliazione, umorismo, sublimazione
6°	Difese ossessive	Annullamento retroattivo, intellettualizzazione, isolamento degli affetti
5°	Difese nevrotiche	Rimozione, formazione reattiva, spostamento
4°	Difese narcisistiche	Idealizzazione, svalutazione, onnipotenza
3°	Difese di disconoscimento	Diniego, proiezione, denegazione
2°	Difese borderline	Scissione, identificazione proiettiva
1°	Difese di azione istintiva	Acting-out, scissione
0	Rottura con la realtà	Negazione psicotica, distorsione psicotica, proiezione delirante

Il prof aggiunge la dimensione dell'**umorismo** come esempio di difesa molto matura: un paziente che fa battute sulla propria malattia non è solo simpatico — è in contatto con la sua situazione e la elabora trasformandola in qualcosa di condivisibile.

Angosce diverse per patologie diverse

Le tre grandi aree psicopatologiche hanno angosce e difese dominanti diverse:

- **Nevrosi** → angoscia di castrazione (di limite, di prestazione)
 - **Psicosi** → angoscia di frammentazione (perdere l'unità della propria identità)
 - **Borderline/Stato limite** → angoscia di abbandono
-
-

Domande di orientamento allo studio

Cosa insegna il mito di Perseo e Medusa sul modo di affrontare la paura? Quali sono i tre messaggi fondamentali?

Il mito trasmette tre lezioni. Prima: le paure, anche le più grandi, si possono affrontare — a condizione di attrezzarsi. Chi si avvicina a Medusa senza preparazione rimane pietrificato. Secondo: occorre un medium — non si guarda la paura frontalmente ma di riflesso. Lo scudo di Atena rappresenta la capacità di riflettere, di mediare l'incontro con la paura visto che visto di riflesso il pericolo è meno deflagrante e più trattabile. Terzo: una volta affrontata, la paura diventa risorsa — la testa di Medusa diventa il "superpotere" di Perseo. Aver elaborato le proprie paure non rende automaticamente esperti delle paure altrui (quello sarebbe empatia egocentrica), ma permette di stare vicino a qualcuno senza essere travolti.

Qual è la differenza tra paura e ansia a livello psicologico e neurologico?

La paura ha un oggetto specifico (una minaccia reale e presente), durata breve e coinvolge principalmente l'amigdala. È funzionale e porta a una risposta comportamentale precisa (fuga, attacco, mimetismo). L'ansia non ha oggetto definito, è proiettata nel futuro, dura nel tempo e coinvolge una struttura diversa, il Nucleo della stria terminale (BNST). Per Plutchik è una combinazione di paura e anticipazione: è la paura privata del suo oggetto e del suo tempo presente. Come metafora: la paura è un imbuto che si restringe verso una minaccia specifica, l'ansia è un imbuto al contrario che si allarga verso l'indeterminato.

In che modo la paura diventa disfunzionale? Descrivi i due meccanismi di inceppamento.

La paura smette di essere funzionale in due situazioni. La prima è l'intensità eccessiva: sopra una certa soglia di arousal si produce il freezing, un blocco totale invece della fuga o dell'attacco. Come nota Freud, quando l'angoscia raggiunge un'intensità eccessiva paralizza ogni azione compresa quella di fuga. Il freezing non è una scelta: è una risposta automatica all'iper-attivazione, e non va interpretata come consenso o passività volontaria. La seconda è la durata eccessiva: un pericolo percepito che perdura consuma le risorse del soggetto e può spingerlo verso soluzioni temporanee (sostanze, farmaci) per sospendere l'esposizione.

Cosa sono i meccanismi di difesa? Contro cosa difendono e come si valuta il loro grado di adattamento?

I meccanismi di difesa (MDD) sono risposte automatiche e inconsce attivate dall'Io sotto la pressione dell'angoscia. Non difendono dalla minaccia esterna, ma dall'angoscia che quella minaccia genera. Questa distinzione è cruciale: il diniego elimina l'angoscia ma non la minaccia reale che continua ad avanzare (come un neo che cambia aspetto). Anna Freud distingue tre fonti di angoscia: istintuale (dall'Es), del reale (dall'esterno) e morale (dal Super-Io). Per valutare se un MDD è adattivo o disadattivo si usano tre criteri: age adequateness (è adeguato all'età?), intensità (quanto distorce la realtà?) e balance (il soggetto usa una varietà di difese o è bloccato sulle stesse?).

Spiega la differenza tra meccanismi di difesa primitivi e maturi. Fai almeno un esempio per ciascun gruppo.

I meccanismi primitivi compaiono nella prima infanzia: sono semplici, molto efficaci nell'eliminare l'angoscia, ma distorcono molto la realtà. Esempio: il diniego — non si percepisce ciò che genera angoscia (i genitori che "non vedono" la dipendenza del figlio). Esempio: la scissione — il mondo diviso in tutto buono o tutto cattivo, senza sfumature. La presenza di meccanismi primitivi in un adulto segnala un grado elevato di angoscia, non una caratteristica di personalità. I meccanismi maturi compaiono dopo la prima infanzia: mantengono un contatto maggiore con la realtà conflittuale e la distorcono meno. Esempio: la

razionalizzazione — si costruisce una spiegazione logica per evitare il contatto emotivo. Esempio maturo per eccellenza: l'umorismo — il paziente che fa battute sulla propria malattia è in contatto con la sua situazione e la elabora trasformandola in qualcosa di condivisibile.

Cosa significa "identificazione proiettiva" e qual è il suo impatto nel lavoro sociale?

L'identificazione proiettiva è un meccanismo complesso: non basta proiettare un contenuto sull'altro, si agisce nella relazione in modo che l'altro provi davvero ciò che gli è stato proiettato. Non è ipocrisia consapevole — è inconscio. Nel lavoro sociale si manifesta quando un utente con vissuto di frustrazione e fallimento porta l'assistente sociale a costruire progetto dopo progetto che fallisce, finché l'operatore prova esattamente le stesse emozioni dell'utente all'inizio: frustrazione, senso di inadeguatezza, rabbia. Ha vissuto dall'interno il mondo interno dell'utente. Riconoscere questo meccanismo permette all'operatore di non confondere le proprie emozioni indotte con una valutazione obiettiva della situazione.

Qual è il criterio orizzontale e il criterio verticale nella classificazione dei meccanismi di difesa?

I meccanismi di difesa si organizzano lungo due assi. L'**asse orizzontale** (criterio temporale) riguarda la comparsa nel tempo dello sviluppo: i meccanismi primitivi compaiono per primi (prima infanzia), quelli maturi emergono più tardi. L'**asse verticale** (criterio qualitativo) riguarda il grado di distorsione della realtà e il livello di complessità: ai livelli bassi troviamo alta distorsione e bassa complessità (es. diniego, scissione); ai livelli alti troviamo bassa distorsione e alta complessità (es. razionalizzazione, umorismo). I due assi si combinano nella scala di maturità di Perrotta (adattata da Pezzoli), che va dal livello 0 (rottura psicotica con la realtà) al livello 7 (difese mature come altruismo, umorismo, sublimazione).

Cosa si intende per "scopo", "modalità d'uso" e "impatto" nei meccanismi di difesa?

Lo **scopo** dei MDD è sempre lo stesso: ridurre l'angoscia che preme sull'Io — non eliminare la minaccia che la genera. La **modalità d'uso** descrive come il meccanismo opera: i primitivi agiscono percettivamente (il diniego blocca la

percezione stessa della realtà angosciante), i maturi agiscono a livello cognitivo-affettivo (la razionalizzazione riorganizza il significato di un'esperienza senza negarla). L'**impatto** misura le conseguenze: i meccanismi con alta distorsione della realtà (livelli bassi) proteggono efficacemente dall'angoscia a breve termine ma impediscono di affrontare il problema reale e limitano la funzionalità; i meccanismi maturi (livelli alti) mantengono il contatto con la realtà e permettono di elaborare l'angoscia senza negarla. La valutazione clinica considera tutti e tre gli elementi insieme ai tre criteri di Anna Freud (age adequateness, intensity, balance).

Come si distribuiscono i meccanismi di difesa nelle principali aree psicopatologiche?

I MDD non si distribuiscono casualmente nelle diverse psicopatologie: riflettono il tipo di angoscia dominante in ciascuna area. Nella **nevrosi** l'angoscia centrale è di castrazione (paura del limite, della prestazione, della perdita) — le difese prevalenti sono quelle nevrotiche di livello 5: rimozione, formazione reattiva, spostamento. Nella **psicosi** l'angoscia è di frammentazione (perdita dell'unità e coerenza del sé) — le difese sono le più primitive, di livello 0-3: negazione psicotica, distorsione, proiezione delirante. Nelle organizzazioni **borderline** (stato limite) l'angoscia dominante è di abbandono — le difese caratteristiche sono quelle di livello 2: scissione e identificazione proiettiva. Riconoscere queste distribuzioni permette all'operatore di orientarsi nel tipo di sofferenza sottostante a partire dal pattern difensivo osservato.

Come describe Biondi la distinzione tra ansia normale e ansia patologica?

Biondi (1996) distingue ansia normale e patologica su sei criteri: intensità (lieve-moderata vs. moderata-intensa), durata (limitata nel tempo vs. lunga o con postumi prolungati), frequenza (episodi rari vs. frequenti o continui), reazione (proporzionata alla situazione vs. inappropriata o sproporzionata), sofferenza soggettiva (limitata e temporanea vs. evidente e frequente), conseguenze funzionali (compromissione minima vs. compromissione della libertà e della funzionalità quotidiana). Il punto discriminante non è la presenza o assenza di ansia — che è normale e adattiva — ma il fatto che diventi cronica, intensa e fuori proporzione rispetto alla situazione.

Domande esame 04

(Estratte da risorse/domande_esame_04.txt)

Definire la paura e le dimensioni che caratterizzano questa emozione.

Vedi risposta: "Qual è la differenza tra paura e ansia..." (per il confronto) e la sezione "Anatomia della paura". La paura ha: oggetto specifico (minaccia reale e presente), valutazione protocognitiva automatica, risposta comportamentale (fuga/attacco/mimetismo), funzione adattiva (protezione/salvezza), durata breve, sede neurologica nell'amigdala.

Reazioni a livello etologico alla paura.

Tre risposte biologiche alla minaccia: fuga (risposta tipica), attacco (quando la fuga è impossibile), mimetismo/immobilità (sparire dalla vista del predatore). Nel lavoro sociale: un utente che attacca durante un colloquio potrebbe essere un "gatto in un angolo" — la risposta etologica all'impossibilità percepita di fuga.

Aspetti che favoriscono o contengono la paura.

Vedi sezione "Il contesto conta" (schema a quattro quadranti). La paura è contenuta da: ambiente familiare/conosciuto, risorse disponibili, supporto relazionale. È amplificata da: ambiente non familiare, storia di esperienze negative con le figure di aiuto, minaccia presente e contesto ostile (area di massimo allarme). L'operatore può agire come "scudo di Atena" — mediare l'incontro con la paura abbassando l'attivazione.

Criterio orizzontale e criterio verticale dei MDD.

Vedi risposta sopra: "Qual è il criterio orizzontale e il criterio verticale..."

Cosa si intende per scopo, modalità d'uso e impatto nei MDD.

Vedi risposta sopra: "Cosa si intende per 'scopo', 'modalità d'uso' e 'impatto'..."

Gerarchia delle difese: differenziazione dei meccanismi di difesa in primari e secondari.

Vedi risposta: "Spiega la differenza tra meccanismi di difesa primitivi e maturi..." e la tabella della scala di maturità nella sezione "La scala di maturità".

Meccanismi di difesa e ambito psicopatologico.

Vedi risposta sopra: "Come si distribuiscono i meccanismi di difesa nelle principali aree psicopatologiche?"

Concetti chiave

Termine	Significato
Paura	Emozione con oggetto specifico (minaccia presente), durata breve, attiva l'amigdala
Ansia	Stato emotivo diffuso senza oggetto specifico, proiettato nel futuro, attiva il BNST
Angoscia	Nel linguaggio freudiano: sia la paura reale che l'ansia nevrotica. In lezione: il disagio profondo che attiva le difese
Freezing	Blocco da iper-attivazione: sopra una certa soglia di arousal ci si paralizza invece di reagire
Meccanismo di difesa	Risposta automatica, inconscia, attivata dall'Io per ridurre l'angoscia (non il pericolo)
Ritiro primitivo	MDD primitivo: disattivazione del contatto con la realtà stimolante
Diniego	MDD primitivo: non si vede (percettivamente) ciò che genera angoscia
Proiezione	Si attribuisce agli altri propri stati interni insostenibili
Introiezione	Si fanno proprie caratteristiche dell'altro

Termine	Significato
Identificazione proiettiva	Si agisce nella relazione in modo da far sì che l'altro provi ciò che gli è stato proiettato
Scissione	Il mondo viene diviso in tutto buono o tutto cattivo, senza sfumature
Idealizzazione/ Svalutazione	Meccanismi speculari: amplificazione delle qualità positive o negative per gestire l'angoscia
Rimozione	MDD secondario: sposta nell'inconscio pensieri/affetti angoscianti dopo un contatto iniziale
Dissociazione	Discontinuità nell'esperienza sensoriale/mnestica, legata ai traumi
Compartimentalizzazione	Due sistemi cognitivi incompatibili coesistono senza mai entrare in contatto
Age adequateness	Adeguatezza all'età: un MDD arcaico in un adulto segnala alta angoscia
BNST	Bed Nucleus of the Stria Terminalis: struttura limbica coinvolta nell'ansia (diversa dall'amigdala della paura)
Empatia egocentrica	Forma scorretta di empatia: "ci sono passato anch'io, so come ti senti" — da evitare

Collegamenti

- **Lezione 01:** introduzione alle emozioni come atto valutativo della realtà; la valutazione protocognitiva già citata.
- **Lezioni successive:** le tre grandi aree psicopatologiche (nevrosi, psicosi, borderline) — i MDD saranno fondamentali per comprenderle.

- **Modulo sulla violenza nelle relazioni intime:** l'ambiente familiare come paradossale fonte di minaccia.
- **Modulo sull'alessitimia:** le emozioni e la difficoltà di riconoscerle e nominarle.
- **Tema aperto — la distanza giusta:** la metafora dei porcospini di Schopenhauer tornerà nel corso.